

1. Пацієнт скаржиться на гарячку, слабкість, задишку, біль у дрібних суглобах кистей, висип у ділянці обличчя. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - $38,4^{\circ}\text{C}$, дифузна алопеція, еритематозний висип на щоках і спинці носа. У загальному аналізі крові: лейкоцити - $3,51 \cdot 10^9/\text{л}$, гемоглобін - 102 г/л , ШОЕ - 56 мм/год , С-реактивний білок - $(++)$. Рентгенологічно виявлено: ексудативний плеврит та перикардит. За результатами біопсії виявлено: гематоксилінові тільця, набухлі ядра загиблих клітин з лізованим хроматином. У загальному аналізі сечі: протеїнурія, змінені еритроцити, лейкоцити. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ревматоїдний артрит
- B. Себорейний дерматит
- C. Розацеа
- D. Системний червоний вовчак
- E. Системний васкуліт

2. Яку специфічну клінічну ознаку виявляють під час кольпоскопії у жінок, хворих на трихомоніаз?

- A. Лейкоплакію
- B. Точкові крововиливи на шийці матки - 'сунична' шийка матки
- C. Фібринозні плівки
- D. Ерозії
- E. Виразку з блискучим дном

3. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на наявність вузлів на обох гомілкях. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох гомілок, переважно у ділянці литок візуалізуються вузли завбільшки з квасолину, щільної консистенції, трохи болісні на дотик. Шкіра над ними інтенсивно-червоного кольору з коричневим відтінком. Подекуди на гомілках відзначаються запальні плями до 5-10 мм у діаметрі, виразки відсутні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вузлувата еритема
- B. Індуративна еритема Базена
- C. Мікробна екзема
- D. Третинний сифіліс
- E. Ліпоїдний некробіоз

4. Пацієнта віком 43 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: токсикодермія. Під час перебування в стаціонарі пацієнт ігнорує факт тяжкості захворювання, вважає, що в такому стані може продовжувати працювати. Укажіть яку

позицію відносин лікаря та пацієнта потрібно використати з таким пацієнтом в контексті еонтологічного підходу.

- A. Інтерпретаційну - переконливий лікар, тривале спілкування лікаря з пацієнтом
- B. Колегіальну - рівноправ'я та взаємна довіра
- C. Інформаційну - безпристрасний лікар та автономний пацієнт
- D. Ліберальну - активна позиція пацієнта
- E. Патерналістську - лікар-опікун, наставник та підопічний

5. У доношеної дитини на 4-ту добу життя на шкірі різних ділянок спостерігаються: еритема, множинні ерозії та тріщини, ділянки відшарування епідермісу. Зовнішній вигляд нагадує опік від окропу. Симптом Нікольського позитивний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Везикулопустульоз
- B. Імпетиго
- C. Бульозний епідермоліз
- D. Справжня екзема
- E. Ексфоліативний дерматит Ріттера

6. Які обов'язкові лабораторні тести необхідно виконати перед початком прийому ізотретиноїну в лікуванні конглобатних акне?

- A. Ліпідограму, печінкові проби, тест на вагітність
- B. Лютеїнізуючий гормон, вільний тестостерон, фолікулостимулюючий гормон
- C. Тест на толерантність до глюкози, загальний рівень IgE
- D. С-реактивний білок, кортизол, сечова кислота
- E. Обстеження на гепатити

7. У трирічної дівчинки після вживання 2-х пігулок еритроміцину спостерігаються такі симптоми: підвищення температури тіла до 40°C , запаморочення, плями на шкірі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізуються міхури до 2-3 см у діаметрі, відшарування епідермісу з утворенням великих ерозій. Симптоми Нікольського позитивні. Ураження на шкірі нагадують опіки 2-го ступеня. Який найімовірніший діагноз?

- A. Синдром Лайєлла
- B. Псоріаз
- C. Поліморфозна ексудативна еритема
- D. Бульозний дерматит

Е. Звичайна пухирчатка

8. Пацієнт віком 26 років скаржиться на вогнище ураження у ділянці правої гомілки. Із анамнезу відомо, що 6 днів тому травмував праву ногу. Об'єктивно виявлено: на шкірі нижньої третини правої гомілки на тлі гіперемії візуалізується виразка з гнійним відокремленням діаметром 3 см, по краю якої спостерігаються товсті, коричнево-чорні кірки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вульгарна ектима
- B. Ускладнений дерматит
- C. Трофічна виразка
- D. Мікробна екзема
- E. Стафілококове імпетиго

9. Лікар-дерматолог у новому колективі не знайшов взаєморозуміння з колегами, до курації тяжких пацієнтів береться неохоче, ігнорує участь у колективних заходах. Який тип регулювання конфлікту наведено в цій ситуації?

- A. Змагання
- B. Співпраця
- C. Пристосування
- D. Уникнення
- E. Компроміс

10. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок. Із анамнезу відомо, що захворювання розпочалося з появи на шкірі тулуба, кінцівок та інших ділянках множинних набряклих овальних плям, спочатку їхній колір був рожевий із фіолетовим відтінком. Діаметр плям поступово збільшувався до 1-20 см і більше, у центрі сформувалось ущільнення. В окремих місцях плями збігли, по периферії (зона росту) зберігалось кільце фіолетового кольору. Об'єктивно спостерігається: шкіра у місці уражень кольору слонової кістки, гладенька, не збирається у складку, на поверхні немає волосся, потовиділення. По мірі прогресування захворювання бузкове кільце зникає, з'являються телеангієктазії та пігментація. З розвитком атрофії ущільнення розсмоктується, шкіра стає тонкою (вигляд «цигаркового паперу»), легко береться в складку і западає. Який найімовірніший діагноз?

- A. Трихофітія гладенької шкіри
- B. Обмежений нейродерміт
- C. Дерматит
- D. Бляшкова склеродермія (локалізована)

Е. Фіксована еритема

11. Пацієнт віком 17 років скаржиться на ясні виділення з уретри, біль на початку сечовипускання. Хворобу пов'язує зі статевим контактом, який був 4 дні тому. Об'єктивно спостерігається: з уретри помітні виділення гною, губки отвору набряклі. Проба Ядасона позитивна, каламутність у першій склянці. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено диплококи. Який найімовірніший діагноз?

- A. Задній гонорейний уретрит
- B. Тотальний гонорейний уретрит
- C. Гонорейний уретропростатит
- D. Передній гонорейний уретрит
- E. Латентна гонорея

12. Яка форма сифілісу проявляється появою на ділянці геніталій виразки блюдцеподібної форми, округлих обрисів, із рівними краями, гладким, блискучим дном, безболісної під час пальпації зі щільно-еластичним інфільтратом в основі, що утворилася через 4 тижні після незахищеного сексуального контакту?

- A. Третинний сифіліс
- B. Вроджений сифіліс
- C. Прихований сифіліс
- D. Первинний сифіліс
- E. Нейросифіліс

13. Хто найчастіше хворіє на симптоматичний урогенітальний кандидоз?

- A. Діти
- B. Хворі на цукровий діабет
- C. Вагітні жінки
- D. Молоді жінки дітородного віку
- E. Молоді чоловіки

14. Куди потрібно направити пацієнта з клінікою синдрому Лайєлла (площа ураження шкіри близько 50%)?

- A. До сімейного лікаря
- B. До дерматовенерологічного відділення
- C. На проведення алергопроб
- D. До реанімаційного відділення
- E. На консультацію до алерголога

15. У шестирічного хлопчика діагностовано стрептококове імпетиго. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для лікування цієї патології?

- A. Тетрациклінова мазь

- B. Сірчана мазь
- C. Мазь Нізорал
- D. Мазь Герпепіві
- E. Мазь Дермовеїт

16. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на ураження шкіри правої гомілки та свербіж. Із анамнезу відомо, що пацієнтка 3 тижні тому травмувала праву гомілку, після чого на шкірі з'явилася рана, яка не загоювалася. Об'єктивно спостерігається: вогнище ураження має чіткі межі, вздовж краю якого наявне відшарування епідермісу, у центрі вогнища на фоні еритеми з ціанотичним відтінком і набряку визначаються мокнучі ерозії, серозно-гнійні кірки, позитивний симптом 'серозні колодязі'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Себореїна екзема
- B. Паратравматична екзема
- C. Професійна екзема
- D. Істинна екзема
- E. Піодермія

17. У чоловіка на шкірі тулуба раптово з'явився сверблячий висип у вигляді розеол, вузликів, міхурів, що розташовуються неупорядковано. Із анамнезу відомо, що висип виник після вживання в їжу креветок. Який найімовірніший діагноз?

- A. Токсикодермія
- B. Екзема
- C. Простий контактний дерматит
- D. Алергічний контактний дерматит
- E. Нейродерміт

18. Який препарат є першою лінією терапії у пацієнтів з конглобатним акне?

- A. Системні ретиноїди
- B. Топічні ретиноїди
- C. Антиандрогенні препарати
- D. Системні антибіотики
- E. Топічний бензоїлпероксид

19. Що з нижченаведеного належить до групи речовин зі шкірноаривною дією?

- A. Іприт
- B. Зарин
- C. Фосген
- D. Синильна кислота
- E. Хлорацетофенон

20. Який мікроорганізм спричиняє бешиху?

- A. Streptococcus haemolyticus
- B. Corinebacterium minutissimum

- C. -
- D. Erysipelotrix insidiosus
- E. Staphylococcus aureus

21. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж у ділянці волосистої частини голови. Об'єктивно виявлено: у ділянці волосистої частини голови спостерігається ураження шкіри, що має вигляд ліхеніфікацій, укритих нашаруванням лусочок, волосся не ушкоджене. Яку лікарську форму для місцевого застосування найбільш доцільно призначити пацієнту в цьому разі?

- A. Пасту
- B. Мазь
- C. Пластир
- D. Лосьйон
- E. Крем

22. Пацієнт віком 46 років, будівельник, скаржиться на появу протягом останніх 6-ти місяців новоутворення на шкірі чола, що періодично кровоточить. Об'єктивно спостерігається: папула із перламутрово-білою поверхнею, судинами в центральній частині та геморагічною кіркою. Який найімовірніший діагноз?

- A. Базальноклітинний рак шкіри
- B. Контагіозний моллюск
- C. Саркома Капоші
- D. Псоріаз
- E. Себореїна кератома

23. У хлопчика віком 13 років батьки помітили вогнище на голові та втрату волосся. Під час огляду виявлено: загальний стан пацієнта задовільний, на шкірі волосистої частини голови у потиличній ділянці круглий осередок правильної форми з білими лусочками, вогнище діаметром близько 3 см з обламаним волоссям на висоті 3-5 мм. Показники загального аналізу крові та сечі в нормі. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено Microsporum lanosum. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту?

- A. Грізеофульвін
- B. Тетрациклін
- C. Ретарпен
- D. Цинктерал
- E. Пеніцилін

24. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкіри з визначенням та розробкою тактики лікування, динамічного спостереження, та реабілітації пацієнта, хворого на atopічний

дерматит. За якою шкалою оцінюється тяжкість атопічного дерматиту?

- A. PGA
- B. BSA
- C. **SCORAD**
- D. DLQI
- E. PASI

25. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль під час сечовипускання та виділеннями з уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри гіперемовані, набряклі, наявні гнійні виділення. Під час проведення двосклянкової проби в першій порції сеча дифузно-каламутна. За результатами бактеріоскопічного дослідження в мазку виявлено підвищену кількість лейкоцитів до 100 в полі зору, розміщені диплококи. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Гострий передній гонорейний уретрит**
- B. Гострий тотальний гонорейний уретрит
- C. Торпідний гонорейний уретрит
- D. Хронічний гонорейний уретрит
- E. Асимптомний гонорейний уретрит

26. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, закладеність вух, оніміння правої кисті й утруднення рухів пальцями. Захворювання почалося гостро. Під час обстеження виявлено зниження тактильної та больової чутливості правої кисті, КСР титр 1:5. Який найімовірніший діагноз?

- A. Спинномозкова сухотка
- B. **Менінгovasкулярний нейросифіліс**
- C. Базальний менінгіт
- D. Сифілітичний неврит
- E. Сифілітичний менгомієліт

27. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість, головний біль, підвищену температуру тіла, болючий висип на бічній поверхні тулуба з лівого боку. Об'єктивно спостерігається: скупчення міхурців із прозорим вмістом, розташованих на гіперемованій шкірі тулуба з лівого боку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Герпетичний дерматоз Дюрінга
- B. Пухирчатка
- C. Простий контактний дерматит
- D. **Оперізувальний герпес**
- E. Мікробна екзема

28. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на шкірі бокової поверхні носа. Із

анамнезу відомо, що вперше помітив невеликий висип близько 2-х років тому, лікувався самостійно мазями без клінічного ефекту. Об'єктивно спостерігається: на боковій поверхні носа з одного боку візуалізується невелика виразка завбільшки з горошину, вкрита геморагічною кіркою, якщо шкіру натягнути, навколо неї стає помітним щільний незапальний валик із дрібними (до 2 мм) білуватими блискучими папулами по периферії. Який найімовірніший діагноз?

- A. Демодикоз
- B. **Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)**
- C. Червоний вовчак
- D. Герпес
- E. Пітиріаз рожевий (Жібера)

29. Яка тривалість інкубаційного періоду при гонорейі?

- A. **від 2-х до 8-ми діб**
- B. 1 місяць
- C. 2-14 днів
- D. 7-14 днів
- E. 7 днів

30. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу висипу, що має вигляд численних лентикулярних, нумулярних вузликів (папул), бляшок, укритих сріблястими лусочками. За результатами гістологічного дослідження рогового шару епідермісу виявлено: ядра та розрив міжклітинних зв'язків. Який найімовірніший патогістологічний діагноз?

- A. **Акантоз**
- B. Гіперкератоз
- C. Папіломатоз
- D. Гранульоз
- E. Паракератоз

31. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі ступень, дискомфорт у ділянці висипу, свербіж. Об'єктивно спостерігається: шкіра міжпальцевих ділянок ступень еритематозна, мацерована, дрібно лущиться, у III та VI міжпальцевих складках є поодинокі тріщини шкіри, що мокнуть. Який найімовірніший діагноз?

- A. Оніходистрофія
- B. Псоріаз
- C. Піодермія
- D. Короста
- E. **Дерматофітія ступні**

32. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на відчуття дискомфорту, збільшення розмірів губ, язика. Із анамнезу відомо, що 10 хв тому пацієнтку вкусила бджола. Об'єктивно спостерігається: набряклі губи та шия, язик ледве вміщається в роті. Набряклі ділянки напружені, неболючі під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- A. Набряк Квінке
- B. Симпато-адреналова криза
- C. Гостра кропив'янка
- D. Напад бронхіальної астми
- E. Анафілактичний шок

33. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на свербіж у ділянці міжпальцевих складок кистей, передньої поверхні пахвових ямок і статевих органів, що виникає переважно у вечірній час. Встановлено попередній діагноз: короста. Який метод дослідження використовують для діагностики корости?

- A. Посів на поживне середовище Сабуро
- B. Метод Дем'яновича
- C. Діаскопію
- D. Метод тонких зрізів лезом
- E. Гратаж

34. Що з нижченаведеного належить до клінічних проявів первинного періоду сифілісу?

- A. Регіонарний лімфаденіт
- B. Горбиковий сифілід
- C. Сифілітична алопеція
- D. Сифілітичний гоніт
- E. Лейкодерма

35. Пацієнту віком 25 років із пневмонією призначено введення цефтріаксону в/м. Через 10 хв після ін'єкції пацієнт скаржиться на напад задишки, стиснення за грудниною, посилився кашель, захриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: набряк шиї та обличчя, АТ - 85/40 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв. Аускультативно в легенях вислуховується велика кількість свистячих та дзижчачих хрипів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Анафілактичний шок
- B. Напад астми
- C. Набряк легень
- D. Ортостатичний колапс
- E. Пневмоторакс

36. Для лікування пацієнта з раннім прихованим сифілісом та строком зараження до 1-го року планується

використовувати бензатину бензилпеніцилін внутрішньом'язово. Оберіть схему застосування лікарського засобу.

- A. Бензатину бензилпеніцилін 4,8 млн. ОД одноразово
- B. Бензатину бензилпеніцилін 2,4 млн. ОД щотижнево протягом двох тижнів (3 дози)
- C. Бензатину бензилпеніцилін 2,4 млн. ОД одноразово
- D. Бензатину бензилпеніцилін 1,2 млн. ОД одноразово
- E. Бензатину бензилпеніцилін 1,2 млн. ОД щотижнево протягом двох тижнів (3 дози)

37. До якого класу сили дії належать мазь клобетазолу?

- A. Надслабкої
- B. Слабкої
- C. Надпотужної
- D. Потужної
- E. Середньої

38. У пацієнтки віком 62 роки в ділянці носогубної складки протягом останніх 1,5-2 років з'явилося новоутворення діаметром 6-7 мм з дерматоскопічними ознаками базально-клітинного раку шкіри. Яка подальша тактика ведення пацієнтки?

- A. Проведення діагностичної біопсії
- B. Лікування топічним іміквімодом
- C. Термінове лікування в онколога
- D. Проведення променевої терапії
- E. Видалення новоутворення шляхом електрокоагуляції

39. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на печію та біль у кутах рота. В анамнезі: цукровий діабет середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: свербіж та обмеження відкриття рота, у кутах рота - рожево-червоні тріщини з білуватим нальотом. У загальному аналізі крові та сечі - нормальні показники. Глюкоза крові - 9 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Щелеподібне імпетіго
- B. Періоральний дерматит
- C. Гальванічний хейліт
- D. Ангулярний кандидоз
- E. Вульгарна пухирчатка

40. Який із нижченаведених діагнозів є підставою для виключення пацієнтів із військового обліку?

- A. Алергічний дерматит із дисемінованим ураженням
- B. Множинні себорейні кератоми
- C. Піодермія дисемінована
- D. Мікоз волосистої частини голови
- E. Атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву

41. Пацієнту віком 24 роки встановлено попередній діагноз: короста. Які елементи висипу характерні для корости?

- A. Коростяні ходи
- B. Вузол
- C. Вузлики
- D. Плями
- E. Міхурці

42. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на наявність сосочкоподібних розростань у ділянці зовнішніх статевих органів. Встановлено попередній діагноз: гострокінцеві кондиломи. Яка найімовірніша причина цієї патології?

- A. Вірус папіломи людини
- B. Сифіліс
- C. Мікоплазма
- D. Вірус простого герпесу
- E. Хламідії

43. Пацієнт віком 25 років скаржиться на появу висипу в ділянці головки статевого члена. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена візуалізується безболісна виразка розміром до 1,5 см у діаметрі без вогнищево-запальних змін, правильної округлої форми, з чіткими межами, піднесена над навколишніми здоровими тканинами. Дно виразки гладке, блискуче, яскраво-червоного кольору, краї пологі (блюдеподібні), незначна серозна ексудация, в основі - 'хрящеподібний' щільноеластичний інфільтрат, пахові лімфатичні вузли збільшені з обох боків, близько 1 см у діаметрі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первинний сифіліс
- B. Простий герпес
- C. Шанкріформна піодермія
- D. Вторинний сифіліс
- E. Третинний сифіліс

44. Яка терапевтична комбінація є ефективною та безпечною у лікуванні вітіліго?

- A. Топічний такролімус + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм
- B. Пеніцилін + полівітамінний комплекс

- C. Івермектин + фотодинамічна терапія
- D. Пульс-терапія ітраконазолом+ фототерапія із псораленом PUVA
- E. Циклоспорин + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм

45. Пацієнт віком 20 років скаржиться на свербіж і біль у ділянці кінчики мізинця правої кисті. Об'єктивно спостерігається: на кінчику мізинця правої кисті візуалізуються згруповані везикули та пустули на еритематозному тлі. Який діагностичний метод дозволить підтвердити діагноз і верифікувати збудник?

- A. УЗД шкіри
- B. Реакція пасивної гемаглютинації
- C. ПЛР
- D. Дерматоскопія
- E. Флуоресценція під лампою Вуда

46. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на ураження шкіри кистей і нижньої третини передпліч. Об'єктивно спостерігається: на фоні гіперемії та інфільтрації візуалізується поліморфний висип у вигляді везикул, ерозій, тріщин і кірок. Який найімовірніший діагноз?

- A. Справжня екзема
- B. Вітряна віспа
- C. Атопічний дерматит
- D. Хвороба Рейно
- E. Хвороба Коксаки

47. У пацієнтки віком 38 років на тлі лікування папуло-пустульозної форми розацеа досягнуто стан клінічної ремісії. Що необхідно заборонити з метою профілактики рецидивів захворювання?

- A. Відвідування лазні
- B. Прийом йодовмісних препаратів
- C. Застосування метронідазолу
- D. Вживання морепродуктів
- E. Застосування системних нестероїдних протизапальних препаратів

48. Які мікроорганізми спричиняють лепру?

- A. Пріони
- B. Гриби
- C. Найпростіші
- D. Віруси
- E. Бактерії

49. У дівчинки віком 15 років після вживання двох таблеток ацетилсаліцилової кислоти через 4-5 годин температура тіла

підвищилася до 39-40°C. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів і відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Об'єктивно спостерігається: ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пухирчатка
- B. Герпетичний дерматит
- C. Токсичний епідермальний некроліз (Лайєлла)
- D. Пемфігоїд
- E. Поліморфна ексудативна еритема

50. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, появу 2-х болючих вузлів у лівій пахвовій ямці та підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно спостерігається: у лівій пахвовій ділянці візуалізуються два вузли до 2 см в діаметрі з бугристою соскоподібною поверхнею, шкіра над ними ціанотично-червона, пальпаторно присутня флюктуація. Який збудник найчастіше спричинює це захворювання?

- A. *Proteus vulgaris*
- B. *Pseudomonas aeruginosa*
- C. *Streptococcus agalactiae*
- D. *Staphylococcus aureus*
- E. *Pityrosporum orbiculare*

51. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на появу висипу в ділянці лівої молочної залози, дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що впродовж 2-х років жінка періодично лікувалася з приводу екземи соска. Ефект був нестійким та невиразним, захворювання поступово прогресувало. Об'єктивно спостерігається: ареола та частково шкіра лівої молочної залози ерозовані, яскраво-червоного кольору, межі вогнища ураження фестончасті, чіткі, місцями валкоподібні. Лівий сосок виглядає як дещо сплюснений, частково утягнений. Пахвові лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, невеликі, рухомі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Реклінгаузена
- B. Хвороба Педжета
- C. Хвороба Боуена
- D. Спіноцелюлярний рак шкіри
- E. Базальноклітинний рак шкіри (базаліома)

52. Пацієнт скаржиться на сильний свербіж протягом місяця та висип між пальцями рук, пахвових западинах, у нижній частині

живота, що посилюється у вечірній час. Об'єктивно спостерігається: на шкірі між пальцями рук, пахвових западинах, у нижній частині живота візуалізуються папульозні попарні елементи, екскоріації. Дерматоскопічно виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях. Який найімовірніший діагноз?

- A. Міаз
- B. Короста
- C. Демодекоз
- D. Педикульоз
- E. Дерматофаз

53. У пацієнтки віком 33 роки під час огляду виявлено: на згинальних поверхнях верхніх кінцівок візуалізуються багаточисленні лентикулярні папули, полігональної форми, ціанотично-червоного кольору, місцями з блиском та западінням по центру вузлика. На слизовій порожнині рота спостерігається білого кольору утворення за типом 'листя папороті'. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє протягом 1-го року. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматит
- B. Короста
- C. Червоний плоский лишай
- D. Парапофіаз
- E. Псоріаз

54. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на м'язову слабкість, біль у суглобах і підвищення температури тіла до 37,5°C) Об'єктивно спостерігається: на шкірі розгинальних поверхонь п'ястно-фалангових суглобів візуалізуються папули рожево-ціанотичного кольору, що частково вкриті лусками. У загальному аналізі крові: ШОЕ - 19 мм/год, лейкоцити - $11 \cdot 10^9/\text{л}$. КФК - 404 Од/л. Який клінічний симптом може доповнювати цей стан?

- A. Нікольського
- B. Периорбітальної 'геліотропної еритеми'
- C. Дар'є-Унни
- D. Бен'є-Мещерського
- E. 'Медяних стільників'

55. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на відчуття печіння у ділянці підборіддя та щік. Об'єктивно спостерігається: у ділянці щік і підборіддя візуалізуються нечисленні папули та пустули на тлі яскравої гіперемії, шкіра в цих місцях чутлива. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний вовчак

- В. Себореїний дерматит
- С. Акне
- Д. Пероральний дерматит
- Е. **Розацеа**

56. У дитини віком 12 років діагностовано дерматит атопічний, ліхеноїдну форму. Після проведеного лікування вогнища ліхеніфікації на шкірі ліктьових і підколінних складок регресували. Який із лікарських засобів необхідно призначити дитині на ці ділянки шкіри у період клінічної ремісії для профілактики загострень атопічного дерматиту?

- А. **Мазь такролімусу 0,03%**
- В. Мазь метилпреднізолону ацепонат 0,1%
- С. Крем із клобетазолом пропіонатом 0,05%
- Д. Крем із мометазоном 0,1%
- Е. Мазь такролімусу 0,1%

57. Пацієнт віком 25 років скаржиться на рясні водянисті виділення з уретри, незначний дискомфорт в уретрі зранку. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому був статевий акт без застосування бар'єрних засобів контрацепції. Об'єктивно спостерігається: губки уретри незначно гіперемовані та набряклі. Який найімовірніший діагноз?

- А. **Мікоплазмоз**
- В. Генітальний герпес
- С. Гонорея
- Д. Трихомоніаз
- Е. Хламідіоз

58. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на запалення слизових оболонок очей, порожнини рота, носа та статевих органів, появу висипу на шкірі, підвищення температури тіла, слабкість. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли після введення протиправцевої сироватки 3 дні тому. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, температура тіла - 41°C, свідомість сплутана, на всій шкірі візуалізуються еритематозні плями з коричневим відтінком, в'ялі міхури, яскраво-червоні зливні ерозії. Виявлено болючість шкіри, під час дотику епідерміс зморщується, на кистях та стопах - відшарування епідермісу у вигляді 'рукавичок та шкарпеток'. Симптом Нікольського різко позитивний. На слизових оболонках поодинокі яскраво-червоні ерозії. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цій ситуації?

- А. **Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення**
- В. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- С. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- Д. Фіксована токсикодермія, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- Е. Герпетиформний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

59. Яку лікарську форму для місцевого застосування необхідно порадити пацієнтам із гострою екземою з явищами мокнущості шкіри?

- А. **Примочки**
- В. Пасти
- С. Мазі
- Д. Анілінові барвники
- Е. Лініменти

60. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначні серозно-гнійні виділення з уретри переважно зранку до сечовипускання та біль під час сечовипускання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 8-ми днів. Об'єктивно спостерігається: незначна набряклість і почервоніння губок уретри. За результатами бактеріоскопічного дослідження зішкрібів з уретри виявлено тільки Гальбершtedтера-Провачека. Який найімовірніший діагноз?

- А. Трихомонадний уретрит
- В. Хронічний гонорейний уретрит
- С. Бактеріальний уретрит
- Д. Гострий гонорейний уретрит
- Е. **Гострий хламідійний уретрит**

61. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль під час сечовипускання, виділення жовто-зеленого кольору із зовнішнього отвору уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри червоного кольору, набряклі. За результатами мікроскопії досліджувального матеріалу, забарвленого за Грамом, у нейтрофілах виявлено розташовані попарно диплококи рожевого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- А. Бактеріальний уретрит
- В. **Гонорейний уретрит**
- С. Кандидозний уретрит
- Д. Трихомонадний уретрит

Е. Хламідійний уретрит

62. Який серологічний тест необхідно виконати на першому етапі обстеження враховуючи сучасний алгоритм проведення серологічного скринінгу та підтвердження діагнозу: сифіліс?

- А. РПГА (реакція пасивної гемаглютинації)
- В. РЗК (реакція зв'язування комплементу з ліпідним антигеном)
- С. РМП (реакція мікропреципітації)
- Д. VDRL (мікрофлокуляційний тест)
- Е. РПР (експрес тест на реакіни плазми)

63. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів. Із анамнезу відомо, що місяць тому мала статевий контакт без застосування бар'єрних засобів захисту. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої великої соромітної губи візуалізується щільний безболісний набряк ціанотично-червоного кольору, від натискування пальцем сліду на ньому не залишається. Пахвинні регіонарні лімфовузли односторонньо збільшені (з боку набряку), щільно-еластичні, безболісні, рухливі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Сифіліс вторинний. Сифілітична ектима
- В. Генітальний герпес
- С. Сифіліс первинний. Індуративний набряк
- Д. Еритразма
- Е. Пахова епідермофітія

64. У трирічної дитини після відвідування басейну з'явився висип на шкірі, що впродовж 4-х днів помітно поширився. Об'єктивно спостерігається: загальний стан дитини задовільний, на шкірі обличчя, шиї та згинальних поверхнях передпліч візуалізуються чисельні плоскі бульозні елементи діаметром 1,5-2 см з тонкою кришкою та серозно-гнійним вмістом, ерозії округлої форми з обривками кришки та тоненькі серозно-гнійні кірочки. Шкіра навколо висипу гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

- А. Червоний вовчак
- В. Імпетиго
- С. Сифіліс
- Д. Алергічний контактний дерматит
- Е. Контагіозний моллюск

65. Яка форма первинної облікової документації заповнюється про випадки захворювання на сифіліс, гонококову,

хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз?

- А. № 089/о
- В. № 063-2/о
- С. № 090/о
- Д. № 089-2/о
- Е. № 089-1/о

66. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на наявність висипу в ділянці геніталій, свербіж та печію. Об'єктивно спостерігається: на шкірі зовнішніх статевих органів наявні згруповані міхурці, заповнені прозорим, місцями каламутним вмістом. Який найімовірніший діагноз?

- А. Сифіліс
- В. Везикулопустульоз
- С. СНІД
- Д. Пахова гранульома
- Е. Генітальний герпес

67. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу безболісної виразки у ділянці статевих губ. Із анамнезу відомо, що мала статевий контакт із малознайомим чоловіком. Яке дослідження потрібно зробити першочергово в цьому разі?

- А. На гриби
- В. На гонококи
- С. На бліду трепонеми
- Д. На хламідії
- Е. На трихомонади

68. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на вогнище ураження на шкірі спини впродовж 2-х років, яке останнім часом почало 'мокрити'. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спини візуалізується вогнище інфільтрації у вигляді бляшки з чіткими контурами овальної форми 2х4 см, застійно-червоного кольору, на поверхні якого є ерозії, поверхневі виразки, кірки, лусочки. Встановлено попередній діагноз: хвороба Боуена. Який метод діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

- А. Дослідження виділень з ерозій і виразок на піогенну флору
- В. Патогістологічне дослідження
- С. Мікологічне дослідження лусочок
- Д. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини
- Е. Дослідження мазків-відбитків на атипіві клітини

69. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції

приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задишки, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ - 110/60 мм рт. ст., ЧСС - 40/хв. Який антидот необхідно застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- А. Гідрокарбонат натрію
- В. Унітіол
- С. Атропін
- Д. Налоксон
- Е. Гіпербарична оксигенація

70. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці тулуба та кінцівок, виражений свербіж шкіри. В анамнезі: хронічний тонзиліт, хронічний гастрит, коліт. Захворювання почалося раптово після укусів комарів. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізується безліч уртикарних, набряклих плям, папул розміром від шпилькової головки до зливних великих вогнищ із фестончатими краями. На окремих ділянках висип регресує. Який найімовірніший діагноз?

- А. Екзема справжня
- В. Екзема мікробна
- С. Токсидермія
- Д. Алергічний контактний дерматит
- Е. Кропив'янка

71. Пацієнт віком 20 років скаржиться на появу болючої виразки на статевому члені, що з'явилася тиждень тому. Об'єктивно спостерігається: виразка з рівними щільними краями, овальної форми, дно виразки вкрито сірувато-зеленкуватими некротичними масами, пальпація виразки болісна. Пахвинні лімфатичні вузли симетрично збільшені до розмірів лісового горіха, не спаяні, болючі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Шанкроїд
- В. Шанкріформна піодермія
- С. Сифіліс первинний
- Д. Короста
- Е. Герпес простий генітальний

72. У пацієнта віком 24 роки під час огляду виявлено: на шкірі тулуба спостерігаються три круглі плями білого кольору з чіткими межами, по краю одного з вогнищ візуалізується гіперпігментація, в уражених ділянках волосся білого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- А. Вітиліго
- В. Сифілітична лейкодерма
- С. Туберозний склероз
- Д. Різнокольоровий лишай
- Е. Стрептодермія

73. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан утворення з визначенням цільового методу видалення. Проводить електрокоагуляцію, фіксує отриманий матеріал для подальшого патогістологічного дослідження. За яким методом електрокоагуляції видаляють епідерматологічні утворення?

- А. Термокаутеризації
- В. Фотодеструкції
- С. Діатермокоагуляції
- Д. Електрофульгурації
- Е. Кріодеструкції

74. Який висип характерний для себорейного дерматиту?

- А. Папули та екскоріації
- В. Пухирі та кірки
- С. Пухирці та ерозії
- Д. Плями та лусочки
- Е. Пухирі та виразки

75. Пацієнт віком 40 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до 38°C, появу 'вузлів' на волосистій частині голови. Із анамнезу відомо, що працює скотарем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі волосистої частини голови візуалізуються осередки уражень, що різко обмежені та вкриті гнійними кірками, після зняття яких із волосяних фолікулів виділяється гній, що нагадує мед у медових стільниках. Який найімовірніший діагноз?

- А. Мікроспорія
- В. Фавус
- С. Сифілітична алопеція
- Д. Інфільтративно-гнійна трихофітія
- Е. Карбункул

76. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу утворень у ділянці статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: на шкірі геніталій наявні сосочкоподібні утворення, що мають ніжку та нагадують кольорову капусту, консистенція їх м'яка, не болючі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий кандидоз
- В. Плоскоклітинний рак
- С. Сифілітичні широкі кондиломи
- Д. Вульгарні бородавки
- Е. Папіломавірусна інфекція

77. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу висипу на обличчі. Об'єктивно спостерігається: у ділянці обличчя візуалізуються численні асимптомні плоскі, тілесного кольору папули. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х років. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сикоз
- B. Розацеа
- C. Акне
- D. Бородавки вульгарні
- E. Бородавки плоскі

78. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу висипу, значний свербіж на шкірі обличчя та кінцівок після укусу оси. Об'єктивно спостерігається: моноформна уртикарна висипка рожевого кольору округлої форми з чіткими контурами, яка незначно підвищується над рівнем шкіри. Який найімовірніший діагноз?

- A. набряк Квінке
- B. Псоріаз
- C. Кропив'янка
- D. Спадковий ангіонабряк
- E. Уртикарний васкуліт

79. У восьмирічної дівчинки на волосистій частині голови виявлено одиничне вогнище діаметром 3 см обляманого волосся на рівні 5-7 мм над шкірою, 'муфтами' та лущенням в основі фолікулів. За результатами мікроскопії встановлено діагноз: мікоз волосистої частини голови. Яке передбачуване джерело інфікування?

- A. Миші
- B. Грунт
- C. Худоба
- D. Забруднені водойми
- E. Кішка

80. Пацієнт віком 35 років скаржиться на свербіж, печіння та помірний біль у ділянці підборіддя і щік. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти років, періодично лікувався різними мазями з тимчасовим успіхом. Останні роки процес повільно прогресує. Об'єктивно спостерігається: у ділянці підборіддя та щік візуалізується велика кількість остіофолікулітів на запальному тлі. Покришка деяких пустул розкрилася та засохла з утворенням зеленкуватих або брудно-жовтих кірочок, під якими помітна ерозивна поверхня. Також спостерігається незначна кількість запальних папул по периферії вогнища. Який найімовірніший діагноз?

- A. Екзема мікробна
- B. Вугрова хвороба
- C. Герпес простий
- D. Атопічний дерматит
- E. Стафілококовий (вульгарний) сикоз

81. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу сверблячих висипань на шкірі. Із анамнезу відомо, що висип з'явився 2 тижні тому після проживання в тимчасовому гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб та контакту з тваринами. Об'єктивно спостерігається: на шкірі живота, міжпальцевих проміжків - папуло-везикульозні елементи, сліди розчухувань, кірочки. Який оптимальний план діагностики для пацієнтки?

- A. Проведення бактеріологічного дослідження висипань для виявлення патогенних мікроорганізмів
- B. Проведення мікроскопічного дослідження на коростяний кліщ
- C. Виконання алергенних проб для визначення можливих причин алергічної реакції
- D. Виконання експрес-тесту на алергічну реакцію до будь-яких домашніх тварин
- E. Консультація з ветеринарним лікарем для вивчення можливого впливу домашніх тварин на здоров'я пацієнта

82. Призначення якого препарату варто уникати під час вагітності?

- A. Тетрацикліну
- B. Магнію сульфату
- C. Фолієвої кислоти
- D. Цетиризину
- E. Лоратадину

83. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкірних покривів із визначенням цільової ділянки. Проводить дерматоскопію, фіксує матеріал для подальшої програмної обробки, оцінює стан шкірних покривів своїх пацієнтів, які мають ризик розвитку онкопроліферативних захворювань шкіри. За якою шкалою оцінюється ризик пігментних уражень шкіри?

- A. АПГАР
- B. Бреслоу
- C. Кларка
- D. ІМТ
- E. Фіцпатрика

84. Пацієнт віком 38 років скаржиться на свербіж, почервоніння, набряклість і мокнуття шкіри кистей. Із анамнезу відомо,

що пацієнт працює на цементному заводі. Хворіє впродовж року з періодичним поліпшенням під час відпустки. Об'єктивно спостерігається: межі ураження нечіткі, на інших ділянках шкіри висип відсутній. Який найімовірніший діагноз?

- A. Екسفоліативний дерматит
- B. Професійна екзема
- C. Себорейна екзема
- D. Хронічна виразкова піодермія
- E. Істинна екзема

85. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла, біль у суглобах та м'язах, появу висипу на шкірі. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 5-ий день після прийому антибіотиків із приводу застуди. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, температура тіла - 39°C, на шкірі розгинальних поверхонь передпліч, тильної сторони кистей, гомілок та стоп - множинний плямисто-папульозний висип, міхурі. За результатами аналізу крові виявлено: лейкоцитоз, лімфопенія, еозинопенія, збільшення ШОЕ. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цьому разі?

- A. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- B. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- C. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- D. Герпетичний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- E. Оперізувальний герпес, визначити ступінь ураження та призначити лікування

86. Пацієнт віком 20 років скаржиться на сильний свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що хворіє з тримісячного віку, захворювання загострюється в холодну пору року. Батько має алергічний риніт. Об'єктивно спостерігається: стійкий білий дермографізм, еритеми, ліхеніфікації, екскоріації на вухах, шиї, тулубі, у ліктьових і підколінних ямках. Який найімовірніший діагноз?

- A. Атопічний дерматит
- B. Простий контактний дерматит
- C. Псоріаз
- D. Себорейна екзема

E. Короста

87. У пацієнтки віком 22 роки під час огляду виявлено: на шкірі лівого крила носа з переходом на шкіру щоки спостерігається вогнище ураження, на еритематозному тлі є горбики розміром з дрібну горошину, коричнево-рожевого кольору, м'якої тістоподібної консистенції з гладенькою, трохи блискучою поверхнею. Висип зрідка вкритий лусочками. Із анамнезу відомо, що хворіє з десятирічного віку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульозний (вульгарний) вовчак
- B. Червоний вовчак
- C. Себорейний дерматит
- D. Червоні (рожеві) вугрі, демодекоз
- E. Вугрова хвороба

88. У шестимісячної дитини з'явився висип на обличчі, що супроводжується свербіжем. Із анамнезу відомо, що дитина захворіла 3 тижні тому після введення прикорму. Об'єктивно спостерігається: на шкірі щік еритема, набряк, дрібні везикули, мокнуття, серозні кірочки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алергічний контактний дерматит
- B. Дитяча екзема
- C. Токсикодермія
- D. Імпетигіо
- E. Мікробна екзема

89. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу безболісного висипу у ділянці правого стегна. Об'єктивно спостерігається: висип у вигляді кільця яскраво-червоного кольору діаметром 10 см, у центрі еритеми на тлі незміненої шкіри наявна папула яскраво-червоного кольору. Із анамнезу відомо, що декілька днів тому жінку вкусив кліщ. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Лайма
- B. Кропив'янка
- C. Бешіха
- D. Системний червоний вовчак
- E. Гостра ревматична гарячка

90. Пацієнт віком 26 років скаржиться на наявність висипань на спині й волосистій частині голови, на розгинальних поверхнях кінцівок. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та волосистої частини голови візуалізуються численні папули яскраво-червоного кольору, поверхня елементів вкрита сріблястими лусочками, подекуди папули зливаються та утворюють бляшки

значних розмірів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розповсюджений псоріаз
- B. Мікроспорія
- C. Себорейний дерматит
- D. Плоский червоний лишай
- E. Алергічний контактний дерматит

91. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на періодичний кашель та появу висипу на шкірі, що поступово поширюється. Із анамнезу відомо, що працює в комунальній службі та часто прибирає сквер - місце скупчення голубів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла - 37,6°C, на шкірі тулуба та кінцівок візуалізуються множинні ізольовані вузли до 2-4 см у діаметрі, помірно щільні, червоно-ціанотичного кольору, у їх центрі - виразки з припіднятими нерівними краями та незначним гнійним виділенням. На слизових оболонках рота виявлено папульозні елементи, схильні до розпаду. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бластомікоз Буссе-Бушке (криптококоз)
- B. Туберкульоз шкіри
- C. Споротрихоз шкірно-лімфатичний, гумозно-виразкова форма
- D. Лейшманіоз
- E. Хромомікоз, вузлова (гумозна) форма

92. У пацієнта віком 30 років під час огляду виявлено: візуалізується висип розміром від 0,5 до 5 см, із навколишнім набряком, межа висипу розмита. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на хронічний тонзиліт упродовж 5-ти років. Які шкірні захворювання мають патогенетичний зв'язок із хронічним тонзилітом?

- A. Остіофолікуліт
- B. Багатоформна ексудативна еритема
- C. Поверхнева стрептодермія
- D. Вузливата еритема
- E. Фурункульоз

93. У пацієнта віком 30 років на розгинальній поверхні кінцівок, шкірі спини спостерігається симетрична висипка вузликів яскраво-рожевого кольору розміром від сечовиці до срібної монети. Поверхня їх вкрита білого кольору лусочками. Симптом Аушпіца позитивний. На схоже захворювання в сім'ї хворіють батько та рідний брат. Який найімовірніший діагноз?

- A. Псоріаз

- B. Атопічний дерматит
- C. Вторинний сифіліс
- D. Туберкульоз шкіри
- E. Червоний плоский лишай

94. Які препарати для зовнішнього застосування призначають для лікування корости?

- A. Емульсію бензілбензоату 20%
- B. Мазь Нізорал
- C. Мазь Дермовейт
- D. Цинкову пасту
- E. Спиртовий розчин йоду

95. У пацієнта віком 22 роки після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Яку невідкладну допомогу необхідно надати першочергово?

- A. Ввести в/м 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну
- B. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- C. Виконати електричну дефібриляцію
- D. Виконати прийом Геймліха
- E. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта

96. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: короста - та призначено місцеве лікування. Який метод місцевого лікування призначається в цьому разі?

- A. 2% саліцилова мазь на 5 діб
- B. 15% сірчана мазь на 3 доби
- C. 3% сірчано-саліцилова мазь на 3 доби
- D. 5% бензілбензоат на 7 діб
- E. 33% сірчана мазь на 5 діб

97. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу висипу на червоній облямівці нижньої губи. Об'єктивно спостерігається: висип у вигляді одиничної округлої ерозії кольору свіжо-розрізаного м'яса розміром 5 мм в діаметрі. Під час пальпації в її основі визначається інфільтрат. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, щільно-еластичної консистенції, рухливі, неболоччі. Якою повинна бути тактика лікаря для встановлення діагнозу: сифіліс?

- A. Обстежити за допомогою ІФА на сифіліс
- B. Обстежити за допомогою РІФ на сифіліс
- C. Провести визначення блідої спірохети за допомогою методу темнопольної мікроскопії

- D. Обстежити за допомогою RW
- E. Спостерігати за станом пацієнтки

98. Пацієнт віком 38 років понад п'ять років тому лікувався через вторинний рецидивуючий сифіліс, лікування не закінчив, змінив місце проживання. Об'єктивно спостерігається: на шкірі чола та носа наявний висип у вигляді горбиків. Реакції РІБТ, РІФ позитивні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вузливатий васкуліт
- B. Третинний сифіліс
- C. Вторинний сифіліс
- D. Туберкульозний вовчак
- E. Туберкульоз шкіри

99. Пацієнт скаржиться на появу сверблячого висипу, що з'явився близько 2-х років тому після стресу. Із анамнезу відомо, що висип посилюється восени та взимку, а влітку майже повністю зникає. Об'єктивно спостерігається: на шкірі ліктів, колін візуалізуються червоні плоскі папули зі сріблястим лущенням. Який симптом необхідно перевірити у пацієнта для підтвердження діагнозу?

- A. Нікольського
- B. Ауспіца
- C. Уікхема
- D. Поспелова
- E. Горчакова-Арді

100. Пацієнт віком 28 років скаржиться на появу після незначної гарячки пухирців на шкірі обличчя та слизовій оболонці рота. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці губ, крилах носа та слизовій оболонці рота ліворуч візуалізуються міхурці діаметром до 2 мм, згруповані по 3-5 міхурців із прозорим та мутним вмістом, ерозії яскраво-червоного кольору з поліциклічними обрисами. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматит герпетиформний
- B. Стрептококове імпетиго
- C. Герпес простий
- D. Стафілококове імпетиго
- E. Пухирчатка еритематозна

101. Згідно з яким наказом МОЗ для поліпшення якості та ефективності надання медичної допомоги пацієнтам із дерматовенерологічними патологіями, подальшого розвитку та удосконалення діяльності дерматовенерологічної служби було затверджено методики діагностики та лікування, їх стандарти, інструкцію з

профілактики трансфузійного сифілісу в роботі станцій переливання крові?

- A. Наказом №163 від 07.12.1992
- B. Наказом №15 від 17.07.1995
- C. Наказом №207 від 07.06.2009
- D. Наказом №33 від 08.08.2004
- E. Наказом №286 від 07.06.2004

102. Пацієнтка віком 73 роки скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навколо трофічної виразки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці виразки шкіра червоного кольору, набрякла, місцями мокнуща, вузлики, пустули, кірочки жовтого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алергічний контактний дерматит
- B. Стрептодермія
- C. Туберкульоз шкіри
- D. Васкуліт
- E. Мікробна екзема

103. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість та відчуття задишки під час незначного фізичного навантаження, дискомфорт через стягування шкіри верхніх кінцівок, грудної клітки, відзначає напади побіління пальців рук, особливо у разі емоційного стресу, біль у суглобах кистей. Об'єктивно спостерігається: обличчя маскоподібне, на шкірі верхніх кінцівок індуративні осередки з ділянками атрофії, відзначається синдром Рейно, рубчики на фалангах пальців та їх деформація. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та розсіяні хрипи над легеньми, тони серця приглушені. У загальному аналізі крові: еритроцити - $3,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 102 г/л, ШОЕ - 24 мм/год. За результатами біохімічного аналізу крові виявлено: СРБ - (++) , фібриноген - 5,2 г/л, загальний білок - 90 г/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний плоский лишай
- B. Піогенний артрит
- C. Системна склеродермія
- D. Системний червоний вовчак
- E. Розповсюджений псоріаз

104. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на свербіж та випадіння волосся. Об'єктивно на волосистій ділянці голови виявлено: візуалізується кільцеподібна пляма червоно-рожевого кольору розміром до 5 см, волосся в місці ураження обламане на одному рівні - вище від поверхні шкіри на 3-6 мм, шкіра гіперемована, вкрита сіруватими дрібними лусочками.

Встановлено попередній діагноз: мікроспорія. Який метод дослідження використовують для діагностики мікроспорії?

- A. Пробу з розчином срібла
- B. Діаскопію
- C. **Посів на поживне середовище Сабуро**
- D. Мікроскопію
- E. Посів на поживне середовище Плоскірева

105. Визначте тип лікування, яке призначається особам, що мали статевий або тісний побутовий контакт із пацієнтом, хворим на заразну форму сифілісу, якщо з моменту відносин минуло не більше ніж 3 місяці.

- A. Скринінгове
- B. Пробне
- C. **Превентивне**
- D. Традиційне
- E. Профілактичне

106. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на свербіж, біль і появу висипу у ділянці головки статевого члена. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена та внутрішньому листку крайньої плоті візуалізуються плямисто-папульозний висип, білі бляшки, пустули, ерозії, набряк, тріщини крайньої плоті. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Кандидозний баланопостит**
- B. Первинний сифіліс
- C. Пріапизм
- D. Контагіозний молюск
- E. Простий герпес

107. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано до відділення реанімації без свідомості. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви рожево-червоного кольору з геморагіями, теплі на дотик, зниці розширені, пульс поверхневий частий, АТ - 110/60 мм рт. ст. Виявлено патологічні рефлексії Бабінського та ригідність потиличних м'язів. Отруєння якою речовиною, ймовірно, відбулося у пацієнта?

- A. Фенолом
- B. ФОС
- C. Бензолом
- D. Синільною кислотою
- E. **Чадним газом**

108. Пацієнт віком 27 років скаржиться на свербіж та печіння у ділянці сечівника, біль у колінному суглобі та відчуття дискомфорту в очах (сльозотеча, свербіж). Який збудник, найімовірніше, спричинив захворювання?

- A. *Candida albicans*
- B. *Neisseria gonorrhoea*
- C. *Trichomonas vaginalis*
- D. ***Chlamydia trachomatis***
- E. *Gardnerella vaginalis*

109. У пацієнтки віком 14 років на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються еритеми, папули, екскоріації. Шкіра дуже суха, відтворюється білим дермографізмом. Загострення виникають після стресу. За результатами дослідження крові виявлено: підвищений вміст імуноглобуліну Е. Який найімовірніший діагноз?

- A. Екзема
- B. Алергічний контактний дерматит
- C. Кропив'янка
- D. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- E. **Атопічний дерматит**

110. Що з нижченаведеного належить до клінічних ознак нейрофіброматозу?

- A. Кавернозна мальформація обличчя
- B. Множинні базаліоми
- C. Кератодермія вздовж ліній Блашко
- D. Телеангіоектазії
- E. **Пляма 'кава з молоком'**

111. Пацієнт скаржиться на появу висипу, біль та печіння у ділянці обох кистей. Виникнення хвороби пов'язує з контактом із формальдегідною смолою. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох кистей візуалізуються еритеми, що мають чіткі межі, везикули, поодинокі міхури. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алергічний контактний дерматит
- B. Токсикодермія
- C. Справжня екзема
- D. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- E. **Простий контактний дерматит**

112. Пацієнт віком 28 років скаржиться на висип та випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: дрібновогнищева алопеція волосистої частини голови, численні рожеваті папульозні висипи на долонях та підшвах. Суб'єктивні відчуття в ділянці висипів відсутні. Пахові, пахові та підщелепні лімфовузли дещо збільшені,

неболючі, мають щільно-еластичну консистенцію, рухливі. Загальний стан - без змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Псоріаз
- B. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- C. Трихофітія
- D. Сифілітична алопеція, долоне-підшвовий папульозний сифілід
- E. Андрогенна алопеція

113. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на виділення з уретри, що супроводжуються болем і різзю під час сечовипускання. Із анамнезу відомо, що симптоматика з'явилася на тлі фізичного навантаження через 3 дні після статевих контактів. Об'єктивно спостерігається: головка статевого члена гіперемована та набрякла, губки зовнішнього отвору уретри почервонілі. З уретри виділяється велика кількість жовто-зеленого гною. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цьому разі?

- A. Гонорея, взяти мазок із уретри на визначення збудника
- B. Хламідіоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест
- C. Уреаплазмоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест
- D. Трихомоніаз, взяти мазок із уретри на визначення збудника
- E. Гарднерельоз, мазок із уретри для ДНК-тестування

114. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу виразки, що розташована на статевому члені. Об'єктивно спостерігається: на статевому члені візуалізується виразка круглої форми з чіткими краями, пахові лімфатичні вузли збільшені, не болючі, рухливі. На шкірі тулуба виявлено дрібні рожеві плями, що не змиваються, не лущаться. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первинний сифіліс
- B. Коростяна ектима
- C. Епітеліома
- D. Шанкриформна піодермія
- E. Вторинний сифіліс

115. Пацієнтка віком 45 років після денного відпочинку на пляжі скаржиться на головний біль, задишку, відчуття пульсації у скронях, шум у вухах, вказує, що 30 хв тому було блювання. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви гіперемовані, шкіра обличчя яскраво-

червона, гаряча на дотик, пульс - 100/хв. Який найімовірніший діагноз?

- A. Отруєння опіатами
- B. Тепловий удар
- C. Симпато-адреналова криза
- D. Сонячний удар
- E. Отруєння метанолом

116. Під час огляду пацієнтки віком 32 роки виявлено: у ділянці живота, тулуба візуалізуються рожево-червоні плями округлої та овальної форми розмірами 9x11 см та 4x7 см, на тлі деяких плям наявні ущільнення, шкіра суха, блискуча з жовтуватим відтінком. Волосся у вогнищах ураження шкіри відсутнє. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматит
- B. Трихофітія гладенької шкіри
- C. Обмежений нейродерміт
- D. Себорейна екзема (білий пітиріаз)
- E. Бляшкова склеродермія (локалізована)

117. Пацієнтка віком 22 роки мала одноразовий статевий контакт без застосування бар'єрних засобів контрацепції з хлопцем, у якого нещодавно було виявлено вторинний свіжий сифіліс. Під час огляду шкіри та досяжних для огляду слизових оболонок висипів не знайдено. Якою повинна бути тактика лікаря-дерматовенеролога у цій ситуації?

- A. Провести серологічне обстеження на сифіліс
- B. Проконсультувати у лікаря-гінеколога
- C. Спостерігати за станом пацієнтки
- D. Провести превентивне лікування сифілітичної інфекції
- E. Проконсультувати у сімейного лікаря

118. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипань на шкірі внутрішньої поверхні передпліч, променевозап'ястних та гомілковостопних суглобів. Об'єктивно спостерігається: монотипний висип у вигляді лентикулярних запальних, блискучих, полігональних папул, на поверхні яких опалоподібні білі або сіруваті смужки. У центрі деяких папул є пупкоподібні вдавлення. Який найімовірніший діагноз?

- A. Контагіозний моллюск
- B. Токсикодермія
- C. Червоний плоский лишай
- D. Псоріаз
- E. Атопічний дерматит

119. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття та появу впродовж останніх 3-х місяців помірно болючого висипу на шкірі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт астеничної статури, на шкірі верхньої половини тулуба, статевому члені та твердому піднебінні візуалізуються дисеміновані соковито-вишневого кольору лентикулярні вузлики з гладенькою поверхнею, а також гіперпигментні плями діаметром 1,5–2 см фіолетового та ціанотично-чорного кольору. За результатами загального аналізу крові виявлено лімфопенію. Який найімовірніший діагноз?

- A. Різнокольоровий лишай
- B. Сифіліс вторинний
- C. Червоний плоский лишай
- D. Саркома Капоші
- E. Множинні невуси

120. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на висип у ділянці бороди та вусів, що супроводжується почуттям печії, свербіжу, поколювання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 1-го місяця, спочатку на підборідді з'явилися окремі пустули з гнійним вмістом, які підсихали з утворенням кірок. На момент огляду процес локалізується на шкірі підборіддя та носогубного трикутника. Шкіра під час пальпації щільна, інфільтрована, ціанотично-червоного кольору. Об'єктивно спостерігається: у ділянці ураження - велика кількість пустульозних елементів, багато з яких пронизані волоссям, множинні брудно-жовті кірки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сикоз стафілококовий
- B. Герпетична інфекція
- C. Мікроспорія
- D. Імпетиго вульгарне
- E. Мікробна екзема

121. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці зовнішніх статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: у ділянці промежини та зовнішніх статевих органів візуалізуються напівкруглі папули тілесного кольору з восковим відтінком, величиною з горошину та із заглибленням у центрі (під час стискання папули виділяється біла сирниста маса). Який найімовірніший діагноз?

- A. Базаліома
- B. Гострокінцеві кондиломи
- C. Сифіліс

D. Червоний вовчак

E. Контагіозний моллюск

122. Пацієнт віком 32 роки, пожежник, після ліквідації пожежі скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, відчуття жару по всьому тілу. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик, температура тіла 40°C, пульс - 110/хв, дихання часте, поверхневе, м'язові посіпування. Який найімовірніший діагноз?

- A. Симпато-адреналова криза
- B. Отруєння чадним газом
- C. ЧМТ
- D. Сонячний удар
- E. Тепловий удар

123. Які з рідкісних захворювань призводять до скорочення тривалості життя пацієнтів або їх інвалідизації?

- A. Дерматит Дюринга
- B. Бульозний епідермоліз
- C. Мікробна екзема
- D. Порокератоз
- E. Вульгарний псоріаз

124. Під час роботи медико-соціальної експертної комісії лікар-дерматолог виявив у пацієнта віком 59 років прогресуючий перебіг псоріазу з ураженням висипаннями понад 70% шкіри, гострий псоріатичний артрит колінних і ліктьових суглобів. Пацієнт безперервно перебуває на лікарняному впродовж 10-ти місяців. Встановлено зниження працездатності до 30% (протягом 5-ти місяців вважається непрацездатним). Яка група інвалідності може бути надана пацієнтові?

- A. 3 група
- B. Тимчасова непрацездатність
- C. 1 група
- D. Вважається працездатним
- E. 2 група

125. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на появу виразки на статевому члені. Об'єктивно спостерігається: виразка округлої форми з чіткими межами, пологими краями, гладеньким дном, дно має вигляд свіжого м'яса, у центрі сальний наліт, шкіра навколо виразки не змінена, пахові лімфатичні вузли з правого боку збільшені, щільні, рухомі, неболючі. На тулубі візуалізуються дрібні рожеві плями, які не лущаться, не турбують. Який найімовірніший діагноз?

- A. Третинний активний сифіліс
- B. Первинний сифіліс
- C. Шанкроїд
- D. **Вторинний сифіліс**
- E. Короста

126. До якої рубрики, згідно з МКХ-10, належить герпетиформний дерматит?

- A. Папулосквамозні порушення
- B. Пемфігоїд
- C. Гранулематозні хвороби шкіри та підшкірної клітковини
- D. Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини
- E. **Інші бульозні порушення**

127. Пацієнт віком 57 років скаржиться на появу висипу на волосистій частині голови, у ділянці шкіри тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Появу висипу пов'язує з нещодавно перенесеною операцією та стресовою ситуацією. Об'єктивно спостерігається: на шкірі візуалізуються запальні папули, що мають тенденцію до розповсюдження та вкриті рихлими сріблясто-білими лусочками. Під час пошкрябування елементів висипу спостерігається симптом 'стеаринової плями', 'термінальної плівки', 'кров'яної роси'. Генеалогічний анамнез не обтяжений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- B. Парасоріаз
- C. Червоний плоский лишай
- D. **Псоріаз**
- E. Дерматофітія

128. У пацієнта віком 35 років під час огляду виявлено: на шкірі тулуба візуалізуються дрібні інфільтровані папули розміром 3-10 мм, рожевого кольору з лускою в центральній частині елементів, що відшаровується по периферії. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Псоріаз**
- B. Іхтіоз
- C. Атопічний дерматит
- D. Мастоцитоз
- E. Краплевидний парасоріаз

129. У пацієнта діагностовано свіжий гонорейний і хламідійний уретрит. Які антибактеріальні лікарські засоби найефективніші в цьому разі?

- A. **Цефтріаксон + азитроміцин**
- B. Ванкоміцин + ципрофлоксацин
- C. Доксициклін + метронідазол

- D. Гентаміцин + ампіцилін
- E. Меропенем + хлорамфінікол

130. У пацієнтки віком 30 років під час огляду виявлено: на волосистій частині голови візуалізуються два нумулярних вогнища облісіння, діаметром 4 та 3.5 см. Позитивний тест натягнення волосся. Під час трихоскопії спостерігається: чорні крапки, обламане волосся, волосся у формі знаку оклику. Встановлено діагноз: гніздова алопеція. Яка тактика лікування пацієнта (І лінія терапії)?

- A. **Топічні кортикостероїди**
- B. Системні кортикостероїди
- C. Топічний міноксидил
- D. JAK-інгібітори
- E. Системні імуносупресанти

131. Який метод використовують для патоморфологічного дослідження пухирних уражень шкіри?

- A. **Визначення симптому Нікольського**
- B. Пробу Томпсона
- C. Дермографізм
- D. Діаскопію
- E. Шкірні проби

132. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на появу висипу в ділянці зап'ястка обох рук, гомілкях, що супроводжується сильним свербіжем. Із анамнезу відомо, що захворювання почалося тиждень тому з появи висипу в ротовій порожнині. Чітко вказати причину появи висипу не може, ні в кого з родичів подібних висипань немає. Об'єктивно спостерігається: у ділянці зап'ястка обох рук, передній поверхні гомілок візуалізуються полігональні, з восковидним блиском папули, червоно-фіолетового кольору з пупкоподібним втисненням у центрі. Наявна сітка Уйкхема. Позитивний симптом Кебнера. У ротовій порожнині на слизовій оболонці щік виявлено білі блискучі папули, що зливаються між собою та утворюють малюнок мережива. Який найімовірніший діагноз?

- A. Псоріаз
- B. Герпетиформний дерматит
- C. Стрептодермія
- D. **Червоний плоский лишай**
- E. Кандидоз

133. Яка шкала дозволяє встановити стадію та тяжкість аденогенетичної алопеції у жінок?

- A. Ludwig
- B. Фіцпатрика
- C. Norwood-Hamilton
- D. Norwood
- E. Hamilton

134. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задишки, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ - 110/60 мм рт. ст., ЧСС - 40/хв. Яка речовина, ймовірно, викликала отруєння?

- A. Азот
- B. Хлор
- C. Аміак
- D. ФОС
- E. Сірководень

135. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип шкіри обличчя та незначний дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х років, висип повільно прогресує. Відзначає, що скарги посилюються у спеку та під час відвідування лазні. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спинки носа з переходом на обидві щоки візуалізується суцільна інфільтрована червона пляма у формі метелика з ціанотичним відтінком, що місцями вкрита білуватими дрібними лусочками. Під час пошкрябування лусочок пацієнт відчуває помірний біль. У центрі ураження шкіри по обидва боки від носа відзначаються невеликі острівці рубцевої атрофії, оточені зоною гіперкератозу. Скарг з боку інших органів та систем немає. Який найімовірніший діагноз?

- A. Акне
- B. Дискоїдний червоний вовчак
- C. Розацеа
- D. Демодикоз
- E. Системний червоний вовчак

136. Жінка віком 31 рік звернулася до лікаря через 10 днів після статевого контакту зі скаргами на виділення із піхви, що мають запах 'тухлої риби'. Який найімовірніший діагноз?

- A. Трихомоніаз
- B. Гарднерельоз
- C. Мікоплазмоз
- D. Гонорея

E. Хламідіоз

137. Пацієнт віком 28 років скаржиться на постійний свербіж та сухість шкіри на руках, ногах і обличчі. Об'єктивно спостерігається: ліхенізація шкіри в місцях згинів, на фоні почервоніння візуалізуються папули та плями на шкірі обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. За результатами загального аналізу крові виявлено підвищений рівень еозинофілів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бешиха
- B. Розповсюджена короста
- C. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- D. Атопічний дерматит
- E. Розповсюджений псоріаз

138. У пацієнта віком 34 роки зі встановленим діагнозом: вторинний рецидивний сифіліс - у першу добу пеніцилінотерапії в шкірно-венерологічному диспансері розвинулась реакція Лукашевича-Яриша-Герксгеймера. Якою має бути лікарська тактика в цьому разі?

- A. Замінити пеніцилін на інший антибіотик
- B. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- C. Спостерігати за станом пацієнта
- D. Ввести пацієнту розчин атропіну
- E. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта

139. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль, печіння під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія, набряклість губок уретри, крихкий 'сирний' наліт, густі білі виділення з уретри з грудками, що нагадують сир. Який найімовірніший діагноз?

- A. Кандидозний уретрит
- B. Бактеріальний уретрит
- C. Хламідійний уретрит
- D. Дріжджовий уретрит
- E. Гонорейний уретрит

140. Який шлях інфікування *Mycobacterium leprae* є основним?

- A. Вживання з їжею моллюсків
- B. Вживання в їжу термічно не обробленого м'яса
- C. Через укуси комарів роду *Anopheles*
- D. Через укуси москітами роду *Phlebotomus*
- E. Тривалий побутовий контакт

141. Який препарат є 3-ю лінією у лікуванні уrogenітального хламідіозу?

- A. Офлоксацин
- B. Канаміцин
- C. Пеніцилін
- D. Біцилін-3
- E. Карбопенем

142. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу висипу та свербіж у ділянці кистей. Із анамнезу відомо, що працює малярем. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей і пальців яскраво-рожевого кольору, трохи набрякла, вогнища запальних плям мають схильністю до периферійного росту і злиття, без чітких меж. Свербіж у ділянці висипу посилюється в разі контакту з водою. Який найімовірніший діагноз?

- A. Короста
- B. Червоний плоский лишай
- C. Простий контактний дерматит
- D. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- E. Алергічний контактний дерматит

143. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок, що супроводжується свербіжем. Об'єктивно спостерігається: на боковій поверхні тулуба, зап'ястках, згинальній поверхні передпліч, гомілкях і слизових оболонках - велика кількість папульозних елементів червоного кольору з ціанотичним відтінком, папули полігональної форми з перламутровим блиском і вдавненням у центрі. На слизовій оболонці порожнини рота візуалізуються ціанотично-червоні папули з білуватою сіткою. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний плоский лишай
- B. Розповсюджений псоріаз
- C. Ексфоліативний дерматит
- D. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- E. Папульозний сифілід

144. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на появу плям темного кольору на обличчі та шії, що поступово збільшуються та темнішають. Із анамнезу відомо, що хворіє близько 2-х років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя та шії візуалізуються дві темні плями з нерівним контуром до 5 см в діаметрі, із лущенням на поверхні. Яке дослідження потрібно провести пацієнту?

- A. Культуральне
- B. Дерматоскопічне
- C. Імунологічне

- D. Трихологічне
- E. Мікроскопічне

145. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан волосистого покриву з визначенням цільової ділянки. Проводить трихоскопію, фіксує матеріал для подальшої програмної обробки, оцінює стан волосяних покривів своїх пацієнтів, які мають ризик ураження волосистої частини. За якою шкалою оцінюється ураження волосистої частини голови?

- A. А. Рука
- B. Фіцпатрика
- C. Hamilton
- D. SCORAD
- E. Ludwig

146. У жінки віком 30 років діагностовано синдром Фітца -Х'ю-Куртіса. Які мікроорганізми спричиняють цей синдром?

- A. Мікоплазми
- B. Гарднерели
- C. Трихомонади
- D. Гонококи
- E. Хламідії

147. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на значні слизово-гнійні виділення зі статевих шляхів, свербіж, печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, біль під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкірних покривів і слизових оболонок зовнішніх статевих органів, внутрішньої частини стегон і перианальної ділянки. Із анамнезу відомо, що мати дитини хворіє на гонорею. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гонококовий вульвовагініт
- B. Уrogenітальний трихомоніаз
- C. Кандидозний вульвовагініт
- D. Бактеріальний вагіноз
- E. Уреаплазмозний вагініт

148. Який із нижченаведених дерматозів є спадковим?

- A. Гемангіома
- B. Еритродермія Лейнера
- C. Бульозний епідермоліз
- D. Пухирчатка акантолітична
- E. Псоріаз

149. Пацієнт віком 30 років скаржиться на появу висипу на статевому члені. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена візуалізується

ерозія блюдцеподібної форми з чіткими межами, червоного кольору, з 'лакованою' поверхнею. Під час пальпації визначається щільно-еластична консистенція ерозії, пахові лімфовузли збільшені до розміру квасолини, безболісні. Реакція Васермана негативна. За результатами темнопольної мікроскопії виявлено бліду трепонему. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сифіліс первинний серонегативний**
- B. Сифіліс вторинний рецидивний**
- C. Туберкульоз шкіри**
- D. Третинний активний сифіліс**
- E. Лепра**

150. Яке порушення відбулося при передачі діагнозу пацієнта сторонній людині?

- A. Право на реабілітаційну допомогу**
- B. Право на медичну таємницю**
- C. Право на вибір лікаря**
- D. Право на обов'язковий медичний огляд**
- E. Право на медичне обслуговування**